

■ 回復期／二重課題

# 回復期の座位二重課題、通常運動を上回る認知・移動改善は示さず

国内125エピソードの観察研究 認知が保たれた層の所見は探索的

遠州病院・浜松医科大学の研究グループが、回復期リハ入院中の高齢者の二重課題エルゴメータを検討した。座位で運動と認知課題を同時に行う訓練79件と、通常運動46件を4週間比較した後ろ向き観察研究。対象は整形外科疾患や脳卒中を主とする125エピソードだった。

開始時の値・年齢・診断で調整後、MMSEの群間差は0.08点(95%CI -0.78～0.93)、TMT-J Part Aは-6.59秒(-22.06～8.87)。二重課題の10m歩行は-0.89秒(-2.77～0.99)、TUGは-0.97秒(-2.62～0.67)で、いずれも有意差はなかった。週6回の訓練に絞った解析も同様だった。

MMSEが27点以上の層では歩行やTUGに改善を示す探索的な所見もあった。著者は仮説を作る段階とし、無作為化試験での確認を求める。「認知が保たれた人には効く」と使い分けを決める根拠ではない。患者ごとの目的と変化を確かめて選びたい。



課題を増やすだけでなく、何を改善したいかを確かめる

出典 **Ann Med** ↗

数字で見る

125件

リハのエピソード

4週間

訓練期間

0.08点

調整後のMMSE群間差

■ 嚥下／口腔

## 唾液と嚥下の関係、研究でばらつき 系統的レビューで介入効果は未確定

米国ウィスコンシン大学などが、唾液と嚥下を客観的に測った研究を系統的にレビュー。4データベースを2025年8月22日まで検索し、流量・粘性・pHなどと嚥下動態を調べた。多くは横断研究で、修正OCEBM尺度ではレベル4だった。

健康成人では流量が多いほど自発嚥下が多い研究があったが、具体的な嚥下動態や神経ペプチド



との関連は一貫しない。対象・採取法・評価法が異なり、唾液を増やす介入の効果は未確定。口腔内の状態を、食形態や嚥下評価と合わせて見る材料になる。

出典 **Dysphagia** ↗

■ 呼吸リハ／継続支援

## COPDで2回目の呼吸リハも改善 429人の観察研究、初回より小幅

オランダCiroで呼吸リハを2回完了したCOPD患者429人の後ろ向き解析。平均62.5歳、予測FEV<sub>1</sub>は43.5%。初回から2回目の開始までに各指標は低下したが、2回目の終了後にも歩行・筋力・症状・生活評価は改善した。

6分間歩行の平均変化は初回 37.0m(95%CI 29.2～44.8)、2回目 27.0m(19.2～34.8)。筋力の改善幅も初回より小



さい。2回とも完了した人に限る対照群のない前後比較で、因果効果は未確定。一度改善して終わりとせず、維持と再評価の必要性を追う材料だ。

出典 **Can J Respir Ther** ↗

短 信

〈教育〉 **ブラジルPTの痛み教育**

教育者89人の調査と23人の面接。痛み教育は断片的で、個人任せの運営や教員研修の不足を報告。

出典 **Musculoskelet Sci Pract** ↗

〈服薬〉 **錠剤嚥下の尺度を検証**

トルコ語PILL-5を成人348人で検証。信頼性は良好だが、予備的な閾値は別集団での検証が必要。 出典 **Dysphagia** ↗

〈脊髄損傷〉 **自己管理の45項目尺度**

中国の脊髄損傷患者295人で信頼性・妥当性を検証。知識や生活行動など5領域を評価する尺度。 出典 **Disabil Rehabil** ↗

〈認知症〉 **運動と生活の質を検討**

台湾の認知症高齢者80人を対象に12週間の運動を検討。QOLに群間差も、無作為化ではない。 出典 **J Gerontol Nurs** ↗

〈脳卒中〉 **在宅日数の起点で差変動**

米国5,943人の観察研究。施設退所から数えると90日の在宅日数差は消失。在院期間の影響に注意。

出典 **Arch Phys Med Rehabil** ↗

〈嚥下AI〉 **VFSS領域抽出の精度**

10研究のメタ解析でDice係数0.83、異質性は高い。画像領域の一致であり、診断精度とは異なる。

出典 **Arch Phys Med Rehabil** ↗

〈脊髄損傷〉 **運動と慢性痛、結果は混在**

46人のRCT。主評価SF-36疼痛は有意差なし。副評価の疼痛強度は改善し、小規模試験として読む。

出典 **Arch Phys Med Rehabil** ↗

〈多疾患〉 **訓練欠席と治療負担**

114人の横断解析。参加が少ない群は自己効力感が低く、治療負担が大きい。欠席理由61%は不明。

出典 **Arch Phys Med Rehabil** ↗